Krankenhaus-Entlassungsbefund

Abteilung für Innere Medizin und Onkologie – Entlassungsmanagement

Alle personenbezogenen Angaben und medizinischen Daten in diesem Dokument sind frei erfunden und ausschließlich für die KI-Challenge 2026 bestimmt.

1. Patientinnendaten

Merkmal	**Angabe**
Name	Anna Berger
Geburtsdatum	14.03.1948
Alter	78 Jahre
Wohnadresse	Musterstraße 12, 1030 Wien
Sozialversicherung	Gesetzlich krankenversichert, ÖGK (fiktive Angabe)
Familienstand	Verwitwet
Wohnsituation	Lebt allein in einer Mietwohnung mit Lift
Entlassungsdatum	29.10.2026
Weiterbetreuung	Hausärztin, onkologische Ambulanz, mobile Hauskrankenpflege

2. Aufnahmediagnosen und medizinische Vorgeschichte

Hauptdiagnose: Lokal fortgeschrittenes Rektumkarzinom mit regionalem Lymphknotenbefall.

Die Patientin befindet sich aufgrund einer schweren bösartigen Tumorerkrankung in onkologischer Behandlung. Nach Abschluss der operativen Erstbehandlung wurde eine ergänzende kombinierte Strahlen- und Chemotherapie eingeleitet. Die Bestrahlung erfolgt ambulant an mehreren Tagen pro Woche. Der Abschluss der geplanten Therapie ist für Mitte November 2026 vorgesehen.

Nebendiagnosen:

- Arterielle Hypertonie, medikamentös behandelt.
- Ausgeprägte therapiebedingte Fatigue mit reduzierter körperlicher Belastbarkeit.
- Wiederkehrende Übelkeit und zeitweise verminderter Appetit.
- Wechselnde Stuhlfrequenz mit zeitweiligen Durchfällen im Zusammenhang mit der onkologischen Therapie.
- Erhöhtes Sturzrisiko bei allgemeiner Schwäche und eingeschränkter Gehstrecke.

- Unterstützungsbedarf bei einzelnen Aktivitäten des täglichen Lebens.

Relevante Vorerkrankungen: Seit mehreren Jahren bestehender Bluthochdruck. Keine bekannten schwerwiegenden Arzneimittelallergien laut vorliegenden Unterlagen.

3. Anlass und Verlauf des stationären Aufenthalts

Die Aufnahme erfolgte aufgrund einer zunehmenden allgemeinen Schwäche, wiederkehrender Übelkeit, verminderter Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme sowie einer vorübergehenden Verschlechterung der Blutdruckeinstellung während der laufenden onkologischen Behandlung.

Im stationären Verlauf erfolgten:

- Klinische Überwachung und Kontrolle der Vitalparameter, insbesondere des Blutdrucks.
- Laborkontrollen einschließlich Blutbild, Elektrolyten und Nierenfunktionsparametern.
- Flüssigkeitssubstitution nach klinischem Bedarf.
- Symptomatische Behandlung von Übelkeit und gastrointestinalen Beschwerden.
- Überprüfung der bestehenden Dauermedikation.
- Mobilisation unter physiotherapeutischer Anleitung.
- Beratung hinsichtlich Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und Umgang mit therapiebedingter Erschöpfung.

Unter den durchgeführten Maßnahmen kam es zu einer klinischen Stabilisierung. Die Patientin ist zum Entlassungszeitpunkt kreislaufstabil und kann mit Unterstützung kurze Strecken gehen. Eine vollständige Wiederherstellung der körperlichen Belastbarkeit ist noch nicht erreicht.

Die ambulante onkologische Behandlung soll nach Rücksprache mit dem behandelnden onkologischen Team fortgesetzt werden.

4. Befund bei Entlassung

Allgemeinzustand: Reduziert, aber stabil.

Bewusstseinslage: Wach, zeitlich, örtlich und situativ orientiert.

Kardiovaskulär: Kreislaufstabil. Arterielle Hypertonie unter bestehender Medikation. Weiterhin regelmäßige Blutdruckkontrollen erforderlich.

Gastrointestinal: Zeitweise Übelkeit und wechselnde Stuhlfrequenz. Orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme möglich, jedoch weiterhin unterstützungsbedürftig.

Mobilität: Selbstständiges Aufstehen mit gelegentlicher Unterstützung. Kurze Gehstrecken mit Rollator möglich. Erhöhtes Sturzrisiko.

Pflegebedarf: Unterstützung beim Duschen, bei der Haushaltsführung und bei einzelnen Alltagstätigkeiten. Medikamenteneinnahme grundsätzlich selbstständig möglich, eine strukturierte Unterstützung und Kontrolle werden empfohlen.

Psychosoziale Situation: Die Patientin ist durch die Krebserkrankung und die regelmäßigen Behandlungstermine belastet. Sie äußert den Wunsch, möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben. Eine Überforderung der vorhandenen familiären Unterstützung soll vermieden werden.

5. Entlassungsmedikation

Medikament / Wirkstoff	**Zweck**	**Hinweise**
Amlodipin	Behandlung des Bluthochdrucks	Regelmäßige Blutdruckkontrolle
Ondansetron	Behandlung von Übelkeit	Nach ärztlicher Verordnung; mögliche Wechselwirkungen beachten
Macrogol	Behandlung einer möglichen Verstopfung	Nur entsprechend der aktuellen Stuhlsituation und ärztlichen Anordnung
Pantoprazol	Magenschutz bei entsprechender Indikation	Einnahme gemäß Medikationsplan
Weitere onkologische Medikamente	Bestandteil der individuellen Krebstherapie	Ausschließlich nach Vorgabe des onkologischen Behandlungsteams

Wichtige Hinweise zur Medikation:

- Der vollständige, aktuelle Medikationsplan ist bei Hausärztin, Onkologie und Apotheke vorzulegen.
- Änderungen der Dauermedikation sollen mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt abgestimmt werden.
- Bei anhaltendem Erbrechen, ausgeprägtem Durchfall, deutlicher Verschlechterung des Allgemeinzustands oder auffälligen Blutdruckwerten ist zeitnah medizinischer Rat einzuholen.

- Bei akuten Warnzeichen wie Bewusstseinsstörungen, starken Blutungen oder schwerer Atemnot ist unverzüglich medizinische Hilfe erforderlich.

6. Empfehlungen für die weitere medizinische Betreuung

6.1 Onkologische Behandlung

- Fortführung der geplanten ambulanten Bestrahlung gemäß onkologischem Therapieplan.
- Regelmäßige Vorstellung in der onkologischen Ambulanz.
- Kontrolle des Blutbildes, der Elektrolyte und der Nierenfunktion nach ärztlicher Festlegung.
- Beobachtung möglicher Nebenwirkungen der Strahlen- und Chemotherapie.
- Überprüfung der Ernährungssituation und bei Bedarf Einbindung einer Ernährungsberatung.

6.2 Hausärztliche Betreuung

- Zeitnahe Kontrolle nach der Entlassung.
- Regelmäßige Blutdruckmessungen und Überprüfung der antihypertensiven Therapie.
- Überprüfung der gesamten Medikation einschließlich möglicher Wechselwirkungen.
- Beurteilung des Flüssigkeitshaushalts und des Ernährungszustands.
- Koordination der fachärztlichen Betreuung und gegebenenfalls Veranlassung zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen.

6.3 Pflege und Betreuung zu Hause

Eine Rückkehr in die eigene Wohnung ist bei organisierter Unterstützung möglich.

Empfohlen werden:

- Mobile Hauskrankenpflege zur Unterstützung bei pflegerischen Aufgaben und zur Beobachtung des Allgemeinzustands.
- Unterstützung bei Körperpflege, Einkäufen, Haushaltsführung und gegebenenfalls Essensversorgung.
- Hilfe bei der Organisation und Wahrnehmung regelmäßiger Bestrahlungstermine.
- Überprüfung der Wohnung auf mögliche Sturzgefahren.
- Einbindung einer Vertrauensperson zur Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben, sofern von der Patientin gewünscht.

Die konkrete Häufigkeit und der Umfang der Betreuung sind im Rahmen eines Entlassungsgesprächs mit der Patientin und den verfügbaren Unterstützungsdiensten festzulegen.

7. Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation

Empfehlung: Prüfung einer stationären onkologischen Rehabilitation nach Abschluss der geplanten Strahlentherapie.

Aufgrund der ausgeprägten Fatigue, der reduzierten körperlichen Belastbarkeit und des bestehenden Unterstützungsbedarfs erscheint eine rehabilitative Maßnahme sinnvoll, sofern die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Mögliche Rehabilitationsziele:

- Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit und Mobilität.
- Aufbau von Kraft und Ausdauer.
- Unterstützung beim Umgang mit therapiebedingter Erschöpfung.
- Ernährungsmedizinische Unterstützung.
- Verbesserung der Selbstständigkeit im Alltag.
- Vorbereitung auf die längerfristige Versorgung zu Hause.

Die konkrete Rehabilitationsform, der Beginn und die Dauer sind nach Abschluss der onkologischen Behandlung und abhängig vom klinischen Zustand festzulegen.

Der Antrag soll rechtzeitig mit dem behandelnden onkologischen Team bzw. der Hausärztin vorbereitet werden. Dabei sind die medizinische Begründung, der voraussichtliche Rehabilitationsbeginn und die zuständige Sozialversicherung zu klären. Die endgültige Entscheidung über die Bewilligung und die geeignete Einrichtung trifft der zuständige Kostenträger.

8. Sozialversicherungsrechtliche und soziale Hinweise

Im Rahmen des Entlassungsmanagements wurden folgende Unterstützungsbedarfe festgestellt:

Medizinische Rehabilitation

- Prüfung der Voraussetzungen für einen stationären onkologischen Rehabilitationsaufenthalt.
- Unterstützung bei der Antragstellung und Zusammenstellung der erforderlichen medizinischen Unterlagen.
- Klärung der Zuständigkeit des zuständigen Sozialversicherungsträgers.

Pflegegeld

- Aufgrund des voraussichtlich längerfristigen Unterstützungsbedarfs soll geprüft werden, ob die Voraussetzungen für Pflegegeld erfüllt sind.
- Ein Anspruch ist nicht automatisch durch die Krebserkrankung gegeben, sondern hängt insbesondere vom Ausmaß des voraussichtlich länger als sechs Monate bestehenden Pflegebedarfs ab.
- Informationen zur Antragstellung und zum zuständigen Entscheidungsträger sollen eingeholt werden.

Mobile Pflege und soziale Dienste

- Kontaktaufnahme mit den zuständigen Wiener Beratungs- und Servicestellen zur Organisation mobiler Pflege und gegebenenfalls weiterer Alltagshilfen.
- Prüfung möglicher Kostenbeiträge, Förderungen und regionaler Unterstützungsangebote.

Heilmittel und Kosten

- Bei entsprechender finanzieller Situation Information über die Voraussetzungen einer Rezeptgebührenbefreiung.
- Klärung möglicher Unterstützungsleistungen für Fahrten zu notwendigen Behandlungsterminen.

Transport zu Bestrahlungsterminen

- Prüfung, ob aufgrund des Gesundheitszustands und der geltenden Voraussetzungen eine medizinisch begründete Transportleistung zulasten des zuständigen Kostenträgers in Betracht kommt.
- Gegebenenfalls ärztliche Bestätigung und vorherige Abstimmung mit dem Kostenträger.

Hinweis: Ob und in welchem Umfang die genannten Leistungen gewährt werden, hängt von den individuellen Voraussetzungen, den geltenden Regelungen und gegebenenfalls einer gesonderten Antragstellung ab.

9. Offene Aufgaben nach der Entlassung

Aufgabe	**Zuständigkeit / nächste Schritte**
Termin zur hausärztlichen Kontrolle vereinbaren	Patientin bzw. unterstützende Vertrauensperson
Weitere Bestrahlungstermine koordinieren	Onkologische Ambulanz und Patientin
Aktuellen Medikationsplan abstimmen	Hausärztin und Onkologie

Mobile Hauskrankenpflege organisieren	Entlassungsmanagement und soziale Dienste
Rehabilitationsantrag vorbereiten	Behandelnde Ärztin bzw. behandelnder Arzt
Pflegegeldanspruch prüfen	Patientin mit Unterstützung der Sozialberatung
Fahrtmöglichkeiten zu Behandlungsterminen klären	Patientin, Sozialberatung und zuständiger Kostenträger
Rezeptgebührenbefreiung prüfen	Patientin bzw. zuständiger Sozialversicherungsträger

10. Zusammenfassende Beurteilung

Die Patientin kann nach klinischer Stabilisierung in ihre häusliche Umgebung entlassen werden. Aufgrund der schweren onkologischen Erkrankung, der noch laufenden Bestrahlung, der therapiebedingten Nebenwirkungen, der bestehenden Hypertonie und der eingeschränkten Mobilität besteht ein erhöhter Bedarf an koordinierter medizinischer und sozialer Betreuung.

Besondere Bedeutung haben die zuverlässige Organisation der weiteren onkologischen Behandlung, die sichere Medikamenteneinnahme, die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks und die Sicherstellung einer ausreichenden Unterstützung im häuslichen Umfeld.

Nach Abschluss der Bestrahlung soll eine onkologische Rehabilitation geprüft und bei entsprechender medizinischer Eignung beantragt werden. Parallel sind mögliche sozialversicherungsrechtliche Leistungen und Unterstützungsangebote abzuklären, um die Selbstständigkeit der Patientin möglichst lange zu erhalten und die Versorgung zu Hause sicherzustellen.

Entlassungsmodus: Entlassung nach Hause mit organisierter ambulanter Weiterbetreuung und empfohlenem sozialmedizinischem Unterstützungsbedarf.